

FICHA TÉCNICA PSICOMÉTRICA

CUESTIONARIO DE RELACIÓN MÉDICO-PACIENTE (CREM-P / PDRQ-13)

Eje VI: Conducta de Salud y Adherencia • Alianza Terapéutica y Confianza Médica de Ruiz-Moral y van der Feltz

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL INSTRUMENTO

Nombre Oficial (Español)	Cuestionario de Relación Médico-Paciente - Versión Pacientes (CREM-P; 13 ítems).
Nombre Original	Patient-Doctor Relationship Questionnaire (PDRQ; van der Feltz-Cornelis et al., 2004).
Autores Originales	Christina M. van der Feltz-Cornelis, M.D., Ph.D. y colaboradores (Vrije Universiteit Amsterdam).
Adaptación Hispana	Roger Ruiz-Moral, M. de Torres-Sánchez, L. A. Pérula-de Torres et al. (Universidad de Córdoba / semFYC, 2007).
Eje Clínico y Constructo	Eje VI: Conducta de Salud y Alianza. Calidad del vínculo interpersonal, empatía y confianza asistencial.
Tipo de Instrumento	Cuestionario de autoinforme estructurado cumplimentado anónimamente por el paciente.
Composición de Ítems	13 ítems puntuados en escala tipo Likert de 5 opciones (1 a 5; rango 13 a 65 puntos).
Población y Rango	Pacientes adultos (≥ 18 años) en seguimiento médico en atención primaria o especializada.
Tiempo de Administración	3 a 5 minutos de cumplimentación autónoma post-consulta médica.
Régimen de Licencia	Acceso abierto para uso clínico de calidad asistencial y proyectos de investigación médica.

2. FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL: LA ALIANZA MÉDICO-PACIENTE

El **CREM-P** adapta a la práctica médica hispanohablante el concepto de alianza terapéutica procedente de la psicoterapia:

- Vínculo y Eficacia Terapéutica:** La literatura médica demuestra que la calidad de la relación médico-paciente es el determinante individual más potente del cumplimiento terapéutico y de los resultados en salud en patologías crónicas.
- Componentes de la Alianza:** Evalúa la sensación de ser escuchado activamente, la confianza en la competencia del facultativo, la sintonía en los objetivos del tratamiento y la disponibilidad de tiempo en consulta.
- Prevención de Conflictos y Demandas:** Puntuaciones deterioradas en el CREM-P alertan precozmente de insatisfacción, búsqueda compulsiva de segundas opiniones o riesgo de conflicto legal por mala praxis percibida.

3. DIMENSIONES EVALUADAS Y COMPOSICIÓN DE REACTIVOS (13 ÍTEMS)

Dimensión del Vínculo	Nº Ítems	Constructo Relacional Explorativo en Consulta
1. Confianza y Alianza Médica	7 reactivos	Seguridad en las decisiones diagnósticas, sensación de “estar en buenas manos”, acuerdo en la medicación y respeto profesional.
2. Empatía y Comuni-cación	6 reactivos	Sensación de ser escuchado con atención, trato humano cálido, claridad en las explicaciones y tiempo dedicado sin prisas.

PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS Y BAREMACIÓN CLÍNICA

4. VALIDEZ, CONFIABILIDAD Y RENDIMIENTO DIAGNÓSTICO EN ESPAÑA / LATAM

Las investigaciones clínicas de validación en atención primaria (Ruiz-Moral et al., 2007; $N > 800$) sustentan su solidez:

Propiedad Psicométrica	Coefficiente / Métrica	Interpretación Metodológica y Evidencia Empírica
Consistencia Interna Total	Alfa de Cronbach = 0.93 - 0.95	Extraordinaria precisión métrica y homogeneidad en los 13 ítems.
Estabilidad Test-Retest	CCI = 0.88 (a 2 semanas)	Elevada consistencia temporal con el mismo médico de cabecera.
Validez Concurrente	$r = 0.72$ con Satisfacción General	Fuerte correlación convergente con escalas de satisfacción del usuario.
Predicción de Adherencia	Odds Ratio = 3.2 ($p < 0.001$)	Predice con gran exactitud el cumplimiento terapéutico en crónicos.
Estructura Factorial	CFI = 0.96; RMSEA = 0.041	El modelo bifactorial presenta un ajuste psicométrico impecable.

5. REGLAS DE CORRECCIÓN Y CÁLCULO DE PUNTUACIONES

- **Opciones de Puntuación:** Cada ítem se califica de 1 a 5 según el grado de acuerdo del paciente: 1 = Totalmente en desacuerdo; 2 = En desacuerdo; 3 = Neutro / Indeciso; 4 = De acuerdo; 5 = Totalmente de acuerdo.
- **Cálculo de la Puntuación Total CREM-P:** Sumatoria directa de los 13 ítems:

$$\text{Puntuación Total CREM-P} = \sum_{i=1}^{13} \text{Ítem}_i \quad (\text{Rango: 13 a 65 puntos})$$

- **Direccionalidad Clínica:** A mayor puntuación, mayor calidad de la relación asistencial y alianza terapéutica percibida. Puntuaciones deprimidas señalan quiebra de la confianza o insatisfacción médica.

6. BAREMOS NORMATIVOS, PUNTOS DE CORTE Y ESTRATIFICACIÓN CLÍNICA

Estratificación	Puntuación Total	Media Ítem por	Estado de la Relación y Alianza Médica (Ruiz-Moral)
Alianza Excelente	58 a 65 puntos	4.5 a 5.0	Confianza y comunicación sobresalientes; altísima probabilidad de adherencia.
Alianza Buena	50 a 57 puntos	3.8 a 4.4	Relación adecuada dentro de la media normativa en centros de salud.
Relación Frágil	40 a 49 puntos	3.1 a 3.7	Punto de corte preventivo quejas de falta de escucha o explicaciones.
Quiebra / Conflicto	< 40 puntos	< 3.1	Riesgo de abandono terapéutico desconfianza grave o conflicto interpersonal.

PUNTO DE CORTE DE ALIANZA CLÍNICA EFECTIVA (CREM-P ≥ 50 PUNTOS):

Una puntuación ≥ 50 puntos (media por ítem ≥ 3.8) define una alianza terapéutica sólida y protectora. Puntuaciones **< 40 puntos** indican una quiebra profunda en la confianza comunicativa, asociándose a una tasa de abandono o incumplimiento farmacológico superior al 65% en pacientes polimedicados.

APLICACIÓN CLÍNICA, CASO ILUSTRATIVO Y REFERENCIAS

7. ALGORITMO DE AUDITORÍA ASISTENCIAL Y MEJORA DE LA ADHERENCIA

PROTOCOLO DE GESTIÓN DE LA ALIANZA MÉDICO-PACIENTE CON EL CREM-P:

- **Paso 1 (Administración Anónima Post-Visita):** Entregar el cuestionario en papel o tableta tras consultas complejas de patología crónica o descompensaciones.
- **Paso 2 (Análisis de los Focos de Insatisfacción):**
 - *Baja puntuación en Empatía (Ítems de escucha y trato):* El paciente percibe que el médico mira la pantalla del ordenador en vez de mirarlo a él; corregir el contacto visual y reformular la escucha reflexiva.
 - *Baja puntuación en Confianza Médica (Ítems de competencia y acuerdo):* El paciente duda del diagnóstico o discrepa con la medicación prescrita; explicar el fundamento farmacológico y consensuar las metas terapéuticas.
- **Paso 3 (Intervención y Reconciliación Asistencial):** Dedicar los primeros 5 minutos de la siguiente visita a explorar las expectativas del paciente para reconstruir el vínculo.

8. CASO CLÍNICO ILUSTRATIVO: RESOLUCIÓN DE INCUMPLIMIENTO EN HIPERTENSIÓN

Identificación: Varón de 62 años con diabetes e hipertensión arterial mal controlada que cambia frecuentemente de médico de cabecera. La enfermera de enlace aplica el CREM-P de forma anónima para evaluar la satisfacción con su actual facultativo.

Evaluación con el Cuestionario CREM-P:

- **Puntuación Total CREM-P = 32 / 65 puntos (Quiebra de Alianza Terapéutica, marcadamente patológico).**
- *Desglose de Ítems Críticos:*
- Ítems de Comunicación: 1 punto ("El médico nunca me mira a la cara; solo teclea en el ordenador").
- Ítems de Confianza: 2 puntos ("Siento que no tiene tiempo para explicarme para qué sirven tantas pastillas").

Intervención Asistencial: El médico revisó el reporte de feedback comunicativo de su centro. En la siguiente consulta, apartó el teclado, mantuvo contacto visual directo y dedicó 10 minutos a revisar juntos cada fármaco, explicando los beneficios específicos y atendiendo sus temores sobre efectos adversos.

Reevaluación a los 3 Meses: La puntuación CREM-P del paciente aumentó a **58 / 65 puntos (Alianza Excelente)**, lográndose una adherencia estricta a la medicación y una normalización de la hemoglobina glicosilada (HbA1c = 6.8%).

9. ALERTAS DE SEGURIDAD Y DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

GARANTIZAR ANONIMATO:

El paciente nunca debe entregar la encuesta directamente a su médico; la falta de anonimato infla artificialmente las puntuaciones por deseabilidad.

PACIENTES CON RASGOS LÍMITE:

En trastornos de personalidad con escisión (idealización/desvalorización), las puntuaciones oscilan bruscamente sin correlato con la praxis médica real.

10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS CIENTÍFICAS

1. Ruiz-Moral, R., de Torres-Sánchez, M., Pérula-de Torres, L. A., et al. (2007). Validación de la versión española del cuestionario de relación médico-paciente (CREM-P). *Atención Primaria*, 39(8), 415-421.
2. van der Feltz-Cornelis, C. M., et al. (2004). The Patient-Doctor Relationship Questionnaire (PDRQ-9) in primary care. *General Hospital Psychiatry*, 26(2), 115-120.
3. Zolnieriek, K. B., & DiMatteo, M. R. (2009). Physician communication and patient adherence to treatment: A meta-analysis. *Medical Care*, 47(8), 826-834.
4. Pérula-de Torres, L. A., et al. (2012). Eficacia de un programa de formación en comunicación asistencial sobre la relación médico-paciente. *Gaceta Sanitaria*, 26(2), 144-152.